

CAVITE BUCCALE OU BOUCHE ET GLANDES SALIVAIRES

Polycopié destiné aux étudiants de deuxième année médecine

Elaboré par le Pr Amrane CY

OBJECTIFS

Connaitre l'anatomie descriptive du vestibule de la cavité buccale

Connaitre l'anatomie descriptive de la cavité buccale proprement dite

Connaitre le Squelette de la langue

Connaitre les muscles de la langue

Connaitre la vascularisation de la langue

Plan du cours

I- Introduction.

II- Anatomie descriptives

A- Vestibule de la cavité buccale.

I- Arcades gingivo-dentaire et dents

B- Cavite buccale proprement dite

1- Voute palatine.

2- Plancher buccal.

C- Glandes annexées à la cavité buccale, glandes salivaires :

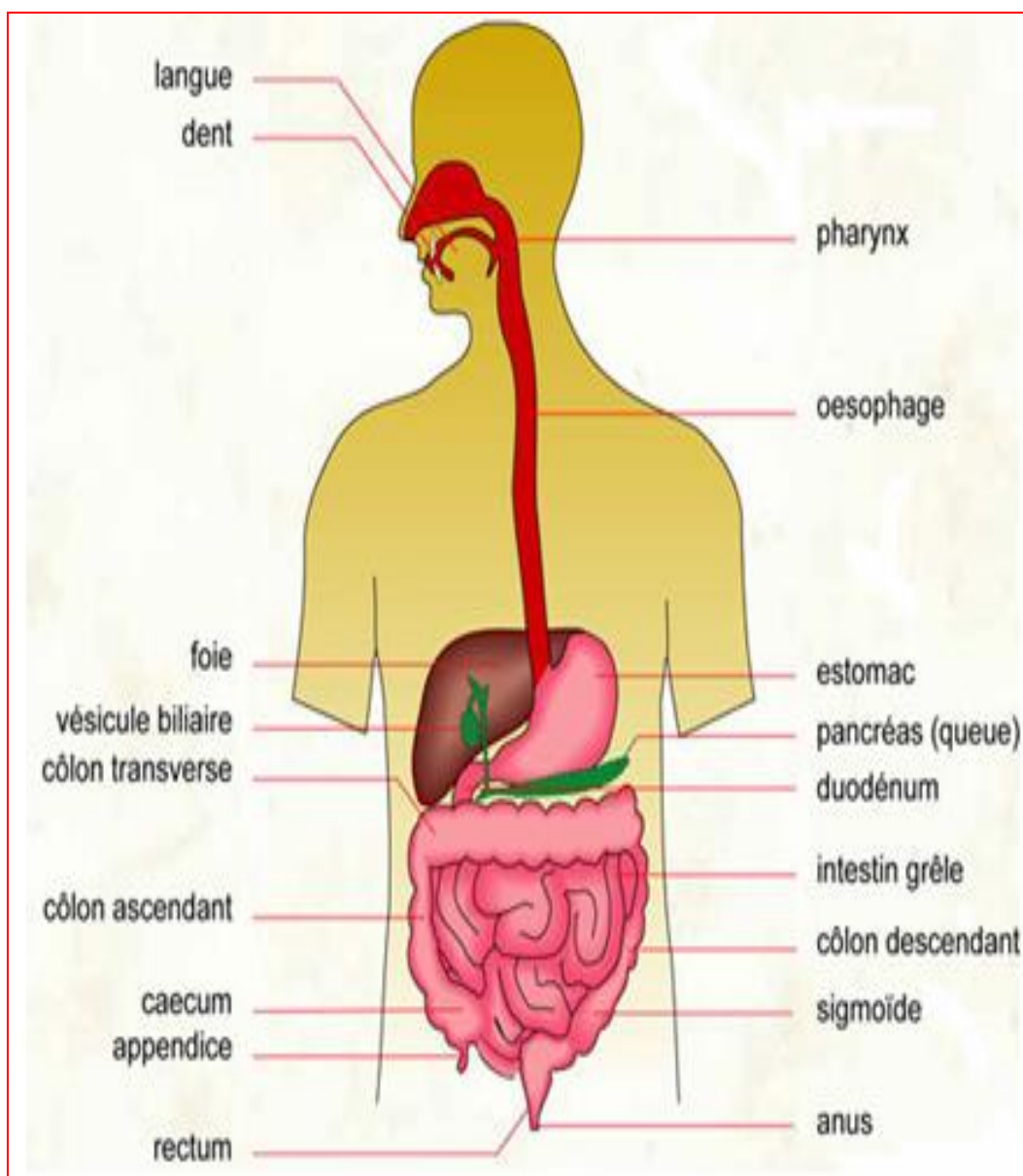
D- Vaisseaux et nerfs

Conclusion

I- Introduction.

La cavité buccale est le premier segment du tube digestif. Elle permet la mastication, la dégustation, l'insalivation des aliments, et l'articulation des mots.

Elle est divisée par les arcades gingivo-dentaires en deux parties, l'une périphérique, ou vestibule de la bouche, l'autre centrale, ou cavité buccale proprement dite



II- Anatomie descriptive.

A- Le vestibule de la cavité buccale

Le vestibule de la cavité buccale est un espace incurvé en forme de fer à cheval, compris entre les arcades alvéolo-dentaires d'une part, les lèvres et les joues d'autre part. La cavité vestibulaire s'ouvre à l'extérieur par l'orifice buccal

1- Gouttières vestibulaires, le vestibule est tapissé par la muqueuse buccale qui forme les gouttières vestibulaires supérieure et inférieure. Chaque gouttière vestibulaire présente un repli muqueux médian, le frein de la lèvre

2- Arcades gingivo-dentaires, au nombre de 2, l'une supérieure ou maxillaire l'autre inférieure ou mandibulaire. Ces arcades supportent les dents, elles sont revêtues d'une muqueuse rose et adhérente, la gencive

Dents: ce sont des organes vivants, dures, blanchâtres, implantés sur le bord alvéolaire des maxillaires, destinées à la mastication des aliments. La dent est formée de

3 parties :- une couronne c'est la partie visible

- une racine

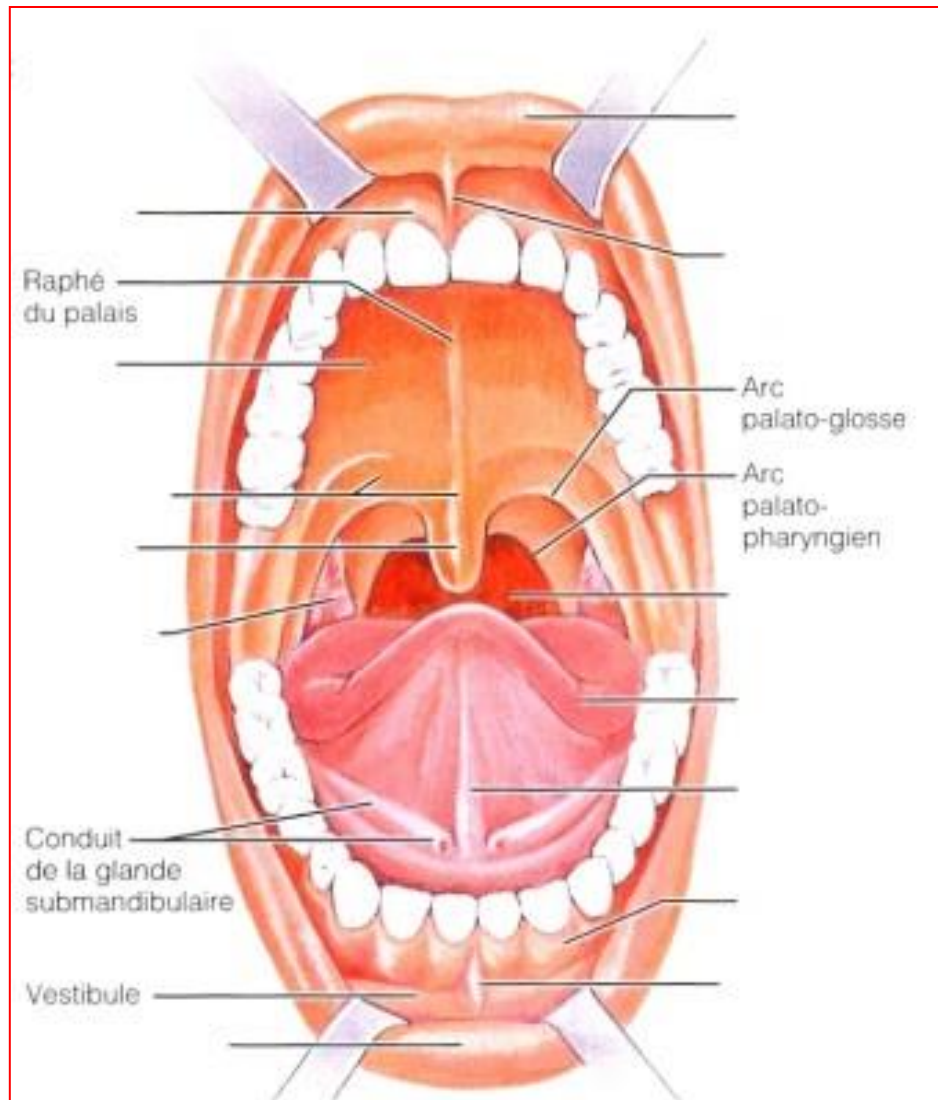
- Le collet une ligne intermédiaire entre les deux .

- **Denture déciduale (lactéale ou temporaire)** = denture de l'enfant de 3 à 5 ans. 10 dents par arcade: 2 incisives centrales, 2 incisives latérales, 2 canines, 2 premières molaires et 2 deuxièmes molaires.
- **Denture permanente** = denture de l'adulte, compte 16 dents par arcade (2 incisives centrales, 2 incisives latérales, 2 canines, 2 premières prémolaires, 2 deuxièmes prémolaires, 2 premières molaires, 2 deuxièmes molaires, 2 troisièmes molaires (dents de sagesse).

3- Lèvres : 2 replis musculo-membraneux mobiles limitant la fente labiale et réunis à leurs extrémités par les commissures labiales droite et gauche. Au nombre de deux supérieure et inférieure possédant chacune une face externe et interne.

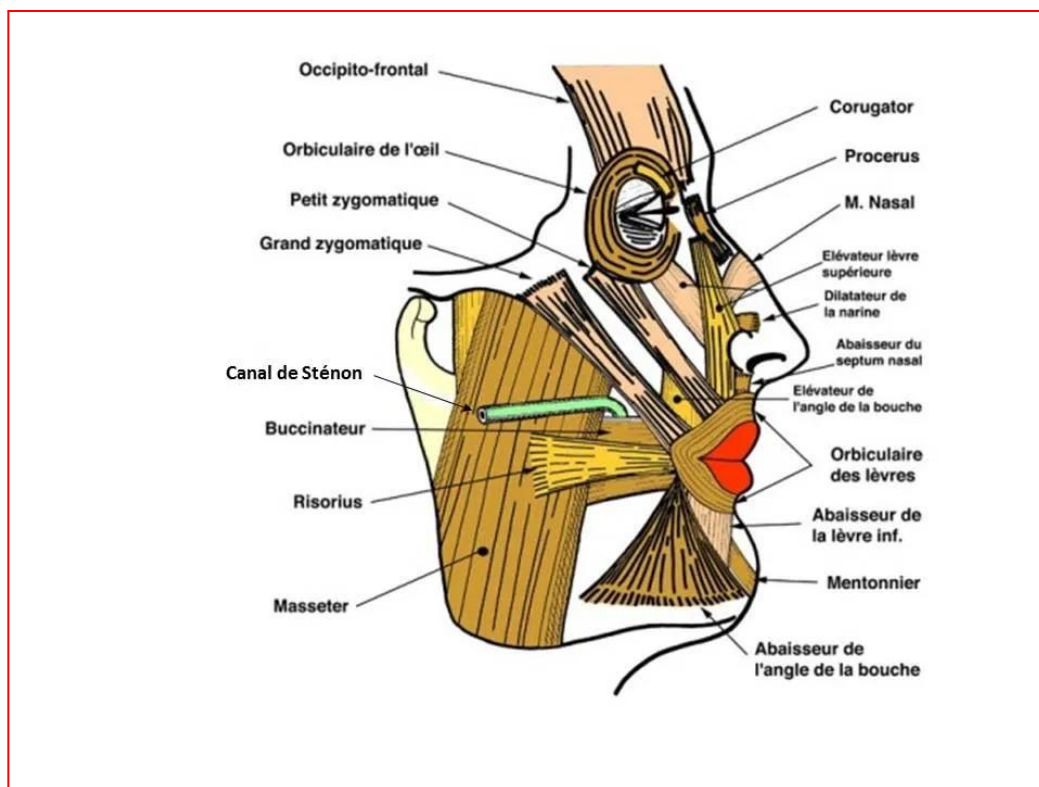
- La face externe : - la lèvre supérieure est séparée de la joue par le sillon naso-labial, elle présente un sillon médian vertical c'est le philtrum. Elle est recouverte par une peau épaisse et pileuse.
 - la lèvre inférieure est séparée du menton par le sillon mento-labial.
- La face interne : pour chaque lèvre, elle répond au vestibule. Elle est unie à la gencive correspondante par un repli muqueux, médian : le frein labial (supérieur et inférieur). Elle est tapissée d'une muqueuse glandulaire sur sa face interne

Les lèvres sont constituées, de l'intérieur à l'extérieur par : la muqueuse glandulaire, le muscle orbiculaire de la bouche et la peau.



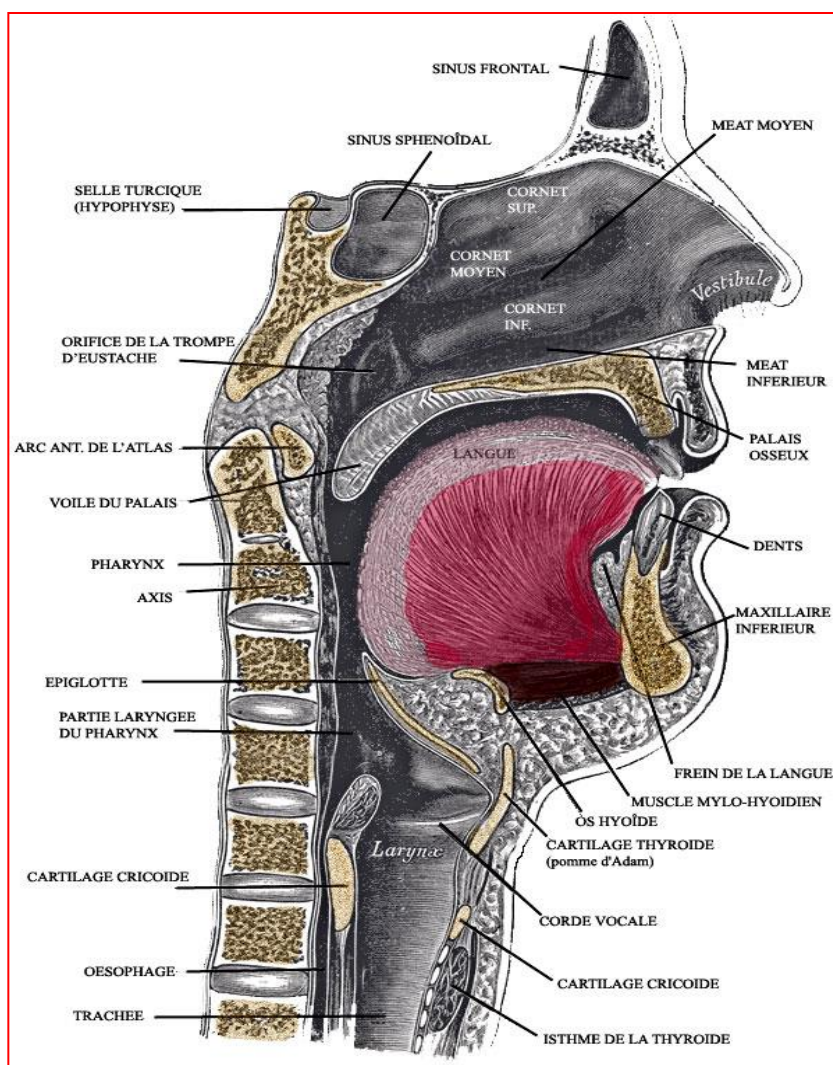
4- Joes, forment les parois latérales du vestibule oral. Constituées de l'intérieur à l'extérieur par :

- la muqueuse buccale qui présente l'orifice du conduit parotidien (de Stenon),
- le muscle buccinateur
- la peau.



B- Cavité buccale proprement dite

La cavité buccale proprement dite est limitée en avant et sur les côtés par les arcades gingivo-dentaires en haut par la voûte palatine, en bas par le plancher buccal sur lequel la langue fait saillie. En arrière, la cavité buccale communique avec le pharynx par un orifice, l'isthme du gosier.



1- PLANCHER BUCCAL (ORAL) : il ferme en bas la concavité mandibulaire. Il est formé de 3 muscles, le génio-hyoïdien, le mylo-hyoïdien, et le digastrique (ventre antérieur). Le plancher buccal est recouvert par la muqueuse buccale. On lui distingue 2 parties, le sillon alvéolo-lingual et la langue.

a- Le sillon alvéolo-lingual, compris entre la racine de la langue et l'arcade gingivo-dentaire inférieure, il présente: *Au milieu, 2 caroncules sublinguales, où s'ouvre chaque conduit submandibulaire (de Wharton).

*Latéralement, 2 plis sublingaux ou éminences sublinguales, où s'ouvrent les canaux excréteurs des glandes sublinguales.

b- La langue

1- Définition : organe du goût, musculaire et muqueux, ovalaire à grosse extrémité postérieure, occupant la partie moyenne du plancher buccal. Elle est formée de 2 parties, une fixe, la racine (ou base) et l'autre mobile et libre, le corps. La langue est l'organe du goût, elle intervient dans la mastication, la phonation et la déglutition.

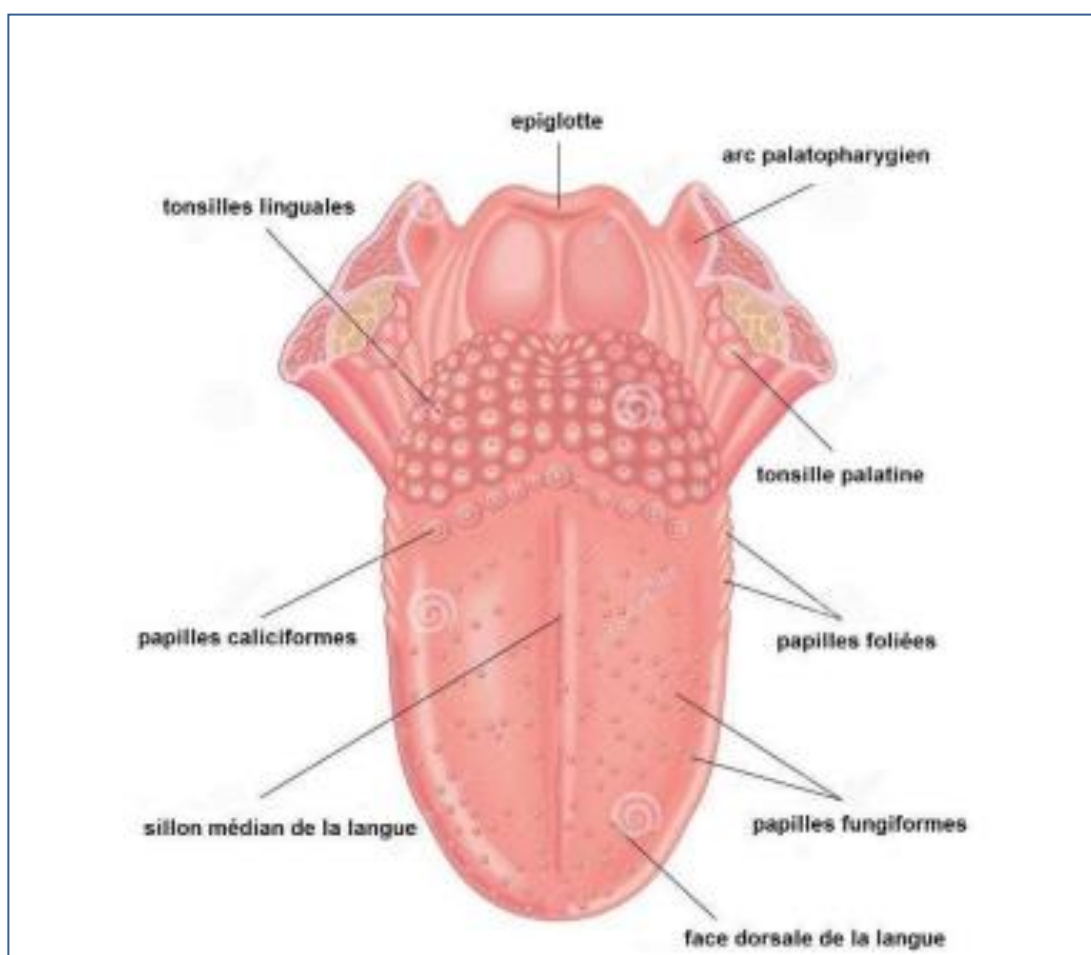
2- Configuration externe : la langue présente à décrire, une face supérieure (ou dos) ; une face inférieure ; deux bords latéraux ; une racine (ou base) et un apex (ou sommet).

- Face supérieure : Traversée par 2 sillons, l'un médian ; l'autre en «V», le sillon terminal, qui présente à son sommet le foramen caecum. Le sillon terminal divise cette face en 2 parties, * une partie antérieure, buccale, présente les papilles linguales (gustatives) et *une partie postérieure, pharyngienne, présente la tonsille (amygdale) linguale, et s'unit à l'épiglote par 3 replis glosso-épiglottiques.
- Face inférieure : présente au milieu, le frein de la langue et latéralement, 2 bourrelets longitudinaux traversés par les veines sublinguales.
- Bords, racine et apex

Bords latéraux : répondent aux arcades dentaires, et présentent les papilles foliées.

Racine : regarde le pharynx. –

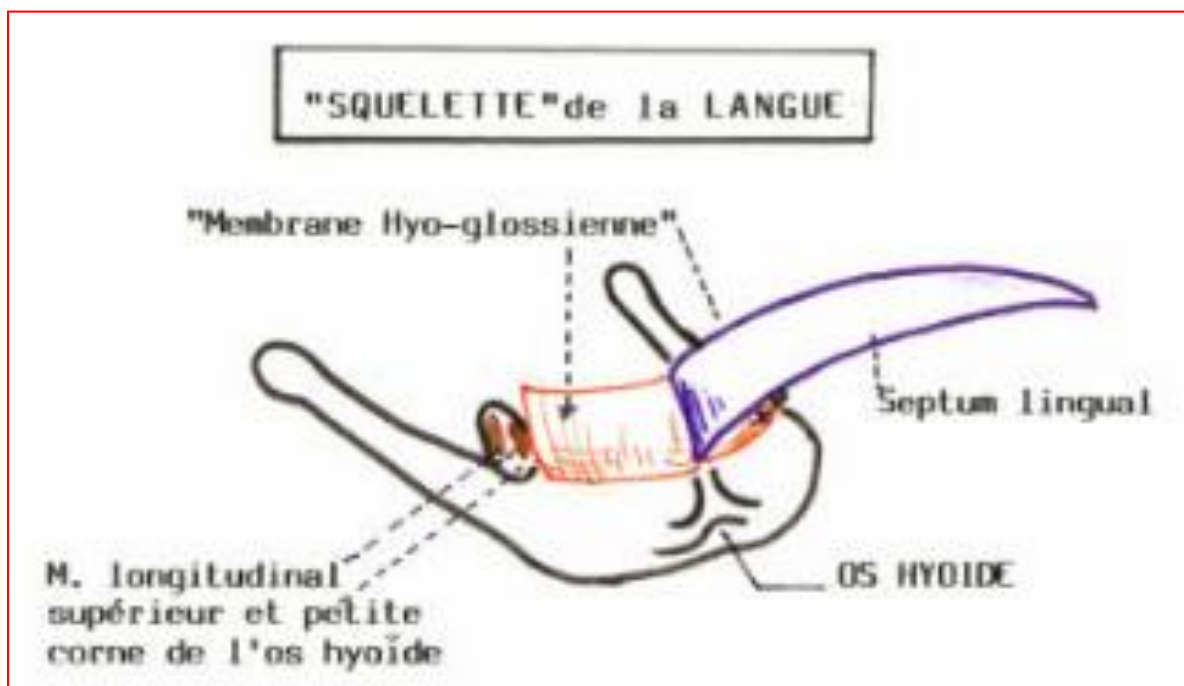
Apex : répond aux incisives.



3- Constitution : La langue est constituée par, un squelette ostéo-fibreux, des muscles, et une muqueuse.

Squelette de la langue

La langue possède une charpente squelettique ostéo-fibreuse formé par : l'os hyoïde, deux membranes fibreuses : la membrane hyo-glossienne et le septum lingual.



Muqueuse linguale :

La muqueuse du dos de la langue est épaisse, elle présente : - En arrière du sillon terminal, les tonsilles linguales.

- En avant, les papilles gustatives (caliciformes, foliées, fungiformes et filiformes).

La muqueuse de la face inférieure est mince et transparente

Muscle :

17 muscles dont 8 pairs et 1 seul impair (lingual supérieur).

Ils sont regroupés en muscles extrinsèques et intrinsèques

- Les muscles extrinsèques

Génio-glosse : applique la langue sur le plancher buccal.

Hyoglosse : abaisse et rétracte la langue.

Stylo-glosse : porte la langue en haut et en arrière.

Palato-glosse (glosso-staphylin) : porte la langue en haut et en arrière ; il rétrécit l'isthme du gosier.

chondro-glosse : attire la langue en arrière et en haut.

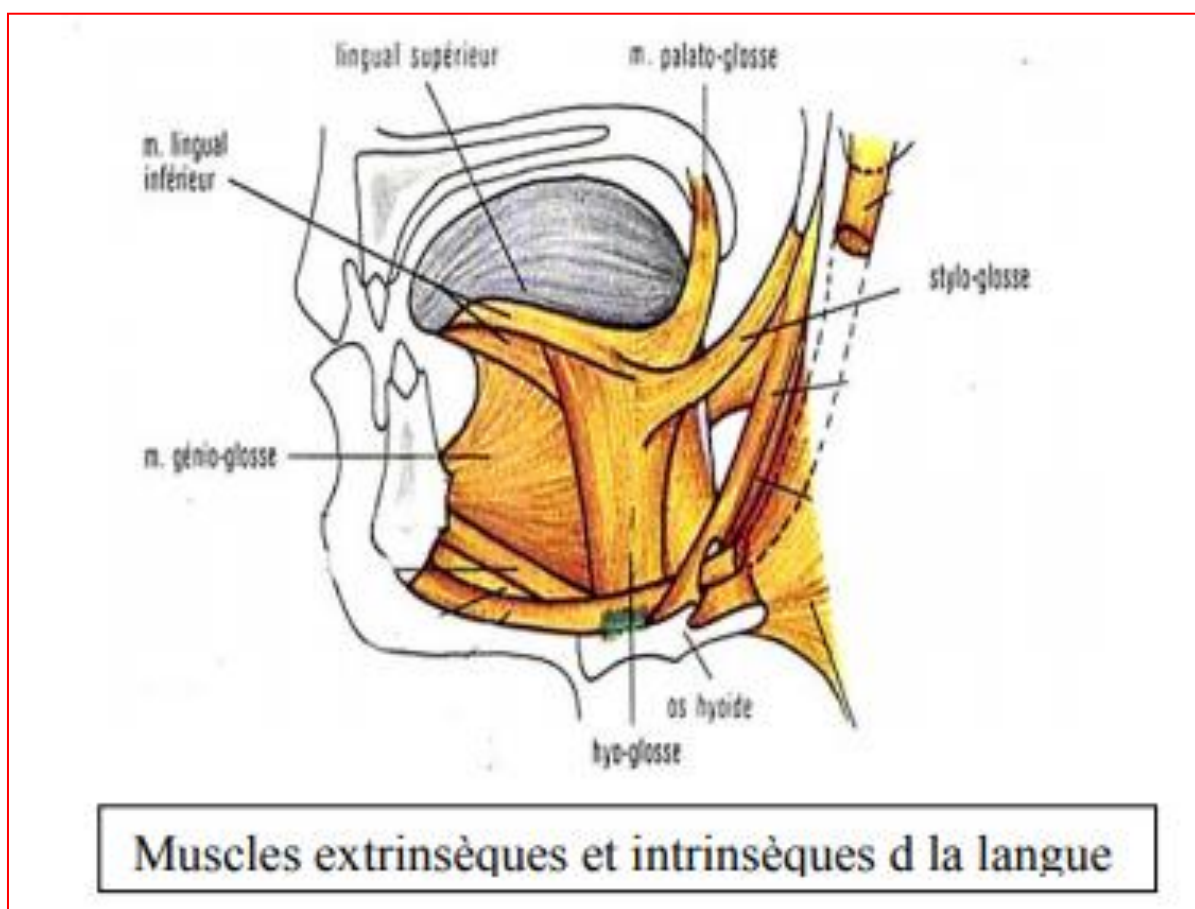
- Les muscles intrinsèques

Longitudinal (lingual) supérieur : abaisse et raccourcit la langue.

Longitudinal (lingual) inférieur : abaisse et rétracte la langue.

Le vertical de la langue : inconstant, il élève la base de la langue.

Transverse de la langue : rétrécit et allonge la langue.



4- Vascularisation :

Artérielle : Artère linguale, branche de la carotide externe

Veineuse : Veine linguale profonde. ♪

Lymphatique : Nœuds lymphatiques submentonniers et submandibulaires.

5- Innervation :

Motrice: - Glosso-pharyngien (IX) et facial (VII) pour les muscles stylo-glosse et palato-glosse.

- Hypoglosse (XII) : autres muscles de la langue.

Sensitive:

- Lingual (branche de V3) pour la zone en avant du sillon terminal.

- Glosso-pharyngien pour la zone en arrière.

- Laryngé supérieur (branche du X) pour les plis glosso-épiglottiques.

Sensorielle (gustative):

- Facial et lingual pour la zone en avant du sillon terminal.

- Glosso-pharyngien pour la zone en arrière

6- Territoires gustatifs

- Amer : papilles du V lingual.

- Acide : papilles des bords latéraux.

- Sucré : papilles de l'apex.

- Salé : papilles de l'apex et des bords.

2- Le palais

Cloison qui sépare la cavité buccale des fosses nasales. Il intervient dans la déglutition, la phonation et l'audition. Constitué par :

- en avant par la voûte palatine (palais dur ou osseux),

- en arrière par le voile du palais (palais mou).

a- Voûte palatine (palais dur) : cloison osseuse horizontale, bordée en avant et latéralement par l'arcade gingivo-dentaire supérieure. Constitution : - plan osseux : formé par l'os maxillaire et l'os palatin.

- plan muqueux :

raphé médian.

tubercule palatin (papille incisive).

crêtes palatines.

b- Voile du palais (palais mou) : cloison fibro-musculaire, mobile, séparant l'oropharynx du nasopharynx. Il se continue en bas et au milieu par l'uvule (luette), d'où se détachent 2 replis pairs : - Pilier antérieur, palato-glosse.

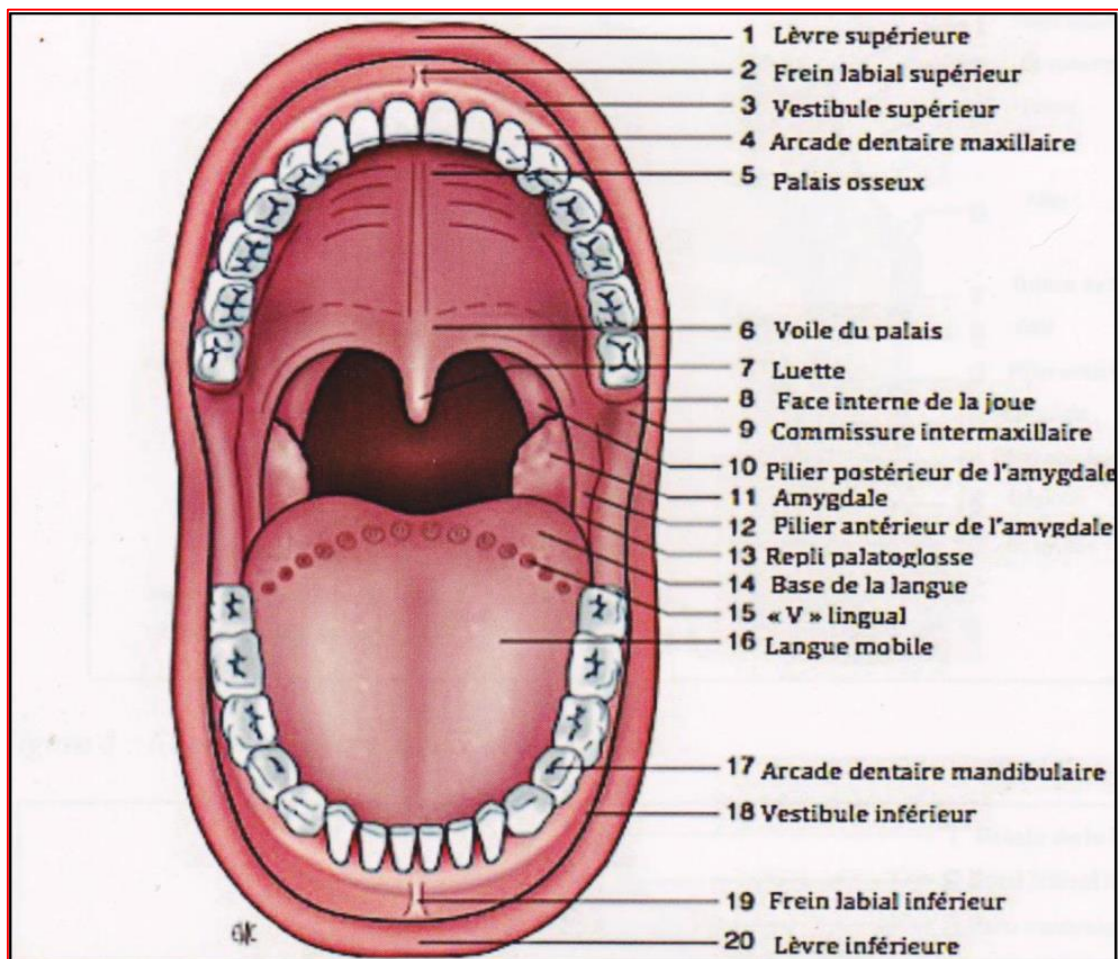
- Pilier postérieur, palato-pharyngien

Les 2 piliers délimitent la fosse tonsillaire (amygdalienne) qui loge la tonsille palatine.

➤ Constitution : Squelette fibreux. Muscles. Muqueuse.

- Squelette fibreux : représenté par l'aponévrose palatine.

- Muqueuse : tapisse les 2 faces du voile.
- Cinq Muscles pairs : palato-glosse (glosso- staphylin), palato-pharyngien (pharyngo- staphylin) ; tenseur du voile (péristaphylin externe) ; élévateur du voile (péristaphylin interne) ; muscle uvulaire (palato-staphylin).



3- L'isthme du gosier : C'est l'Ouverture de la cavité buccale dans l'oropharynx, limitée par : Le palais mou en haut

La fosse tonsillaire latéralement (contient la tonsille palatine).

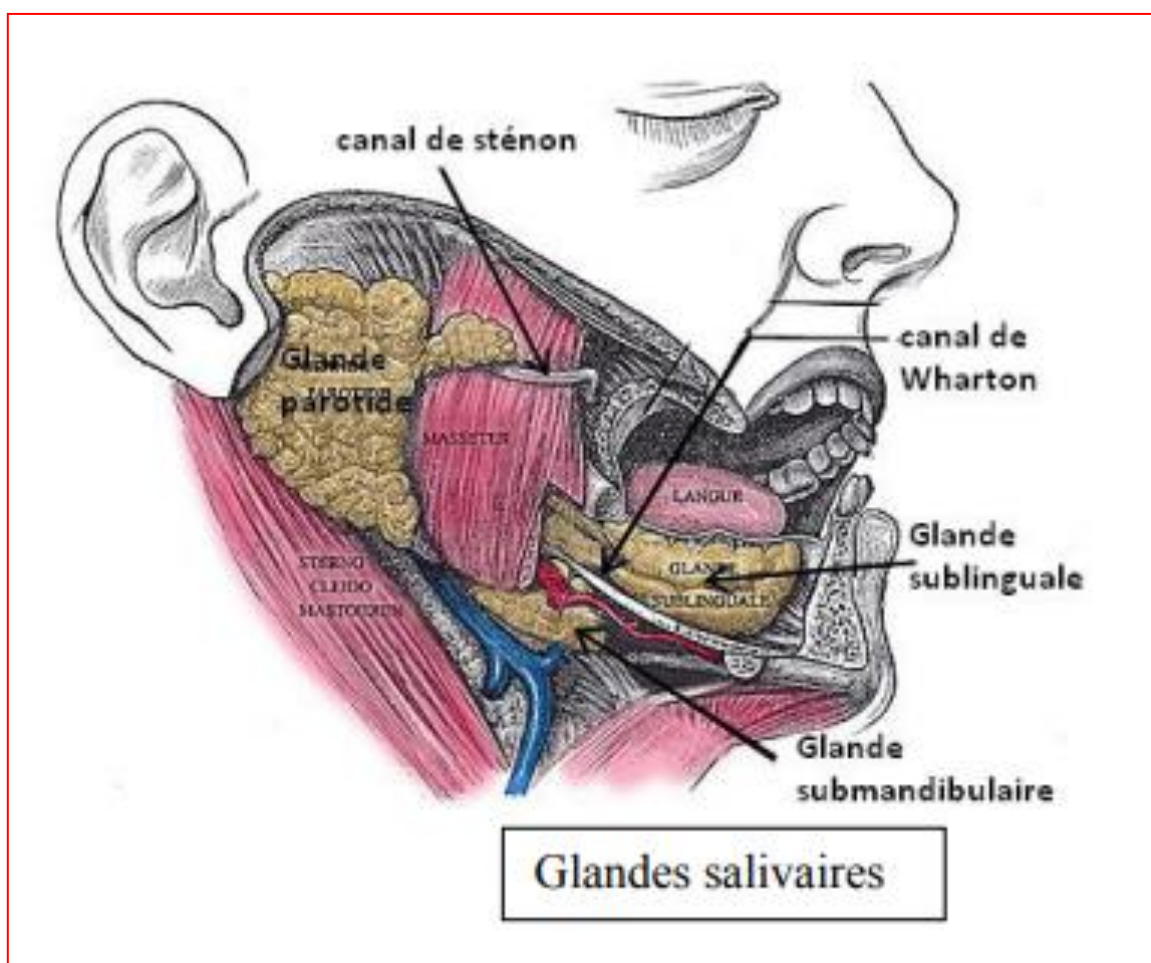
La racine de la langue en bas.

C- LES GLANDES SALIVAIRES

Elles sécrètent la salive, dont les principaux rôles sont l'aide à la mastication, à la digestion et la protection de la muqueuse buccale

- Petites glandes : celles-ci sont disséminées sur toute l'étendue de la muqueuse buccale. Elles se répartissent en quatre groupes principaux qui sont les glandes palatines, les glandes labiales, les glandes jugales et les glandes linguales.

- Grosses glandes ou glandes salivaires proprement dites : on compte de chaque côté trois glandes salivaires qui sont, d'arrière en avant : la parotide, la sous-maxillaire et la sublinguale.
 - glande parotide: la plus volumineuse, située en arrière de la branche montante de la mandibule, et au dessous du conduit auditif externe, formée par 02 lobes ; superficiel et profond entre lesquels circule le nerf facial et les vaisseaux nourriciers. Le canal excréteur est le canal de Stenon qui s'abouche en regard de la 2ème molaire du haut.
 - glande sous mandibulaire: située à la partie latérale de la région sus hyoïdienne, de taille variable, le canal de Wharton est son canal excréteur
 - la glande sub linguale: dans le plancher buccale, c'est un ensemble de petites glandes et possède plusieurs canaux excréteurs.



Conclusion

La cavité buccale est une structure importante du système digestif et de l'appareil respiratoire chez les humains et les animaux. Elle est composée de divers éléments, tels que les dents, les gencives, la langue, les glandes salivaires et la luette.

La fonction principale de la cavité buccale est de permettre l'ingestion et la préparation des aliments avant leur passage dans le système digestif. La langue et les dents aident à mâcher les aliments et à les fragmenter en morceaux plus petits pour faciliter la digestion

La salive produite par les glandes salivaires contient des enzymes qui aident à décomposer les aliments, ainsi que des agents antimicrobiens qui contribuent à maintenir une bonne santé bucco-dentaire

En plus de sa fonction digestive, la cavité buccale joue également un rôle important dans la parole et la respiration. La langue, les lèvres et les dents aident à produire différents sons pour la parole, tandis que la cavité buccale et les voies respiratoires permettent la respiration. Cependant, la cavité buccale peut également être le siège de diverses affections, telles que les caries dentaires, les maladies des gencives et les cancers de la bouche. Il est donc important de prendre soin de sa santé bucco-dentaire en adoptant de bonnes habitudes d'hygiène, en évitant le tabac et en limitant la consommation d'alcool

Références bibliographiques

- 1- Bouchet, A., & Cuilleret, J. (2016). Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle. Paris: Elsevier-Masson.
- 2- Netter, F. H. (2017). Atlas d'anatomie humaine. Paris: Elsevier-Masson.
- 3- Rouvière, H., & Delmas, A. (2014). Anatomie humaine: descriptive, topographique et fonctionnelle. Paris: Elsevier-Masson.
- 4- Sobotta, J., & Putz, R. (2017). Atlas d'anatomie humaine. Paris: Elsevier-Masson.
- 5- Testut, L., & Latarjet, A. (2016). Traité d'anatomie humaine. Paris: Elsevier-Masson.
- 6- Scully C, Cawson RA. Medical problems in dentistry. Elsevier Health Sciences; 2010
- 7- Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC. Oral and maxillofacial pathology. Elsevier Health Sciences; 2015
- 8- Sturdevant CM, Roberson TM, Heymann HO, Sturdevant JR. The art and science of operative dentistry. Elsevier Health Sciences; 2018